

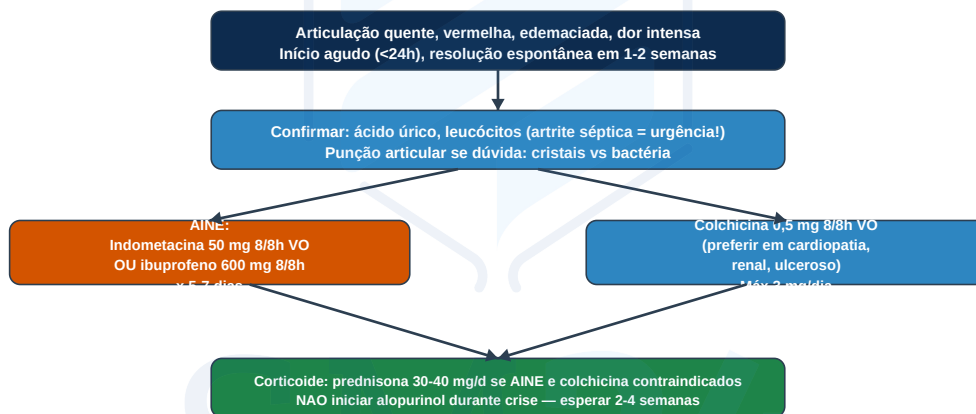
GOTA — ANTI-INFLAMATÓRIO + PROFILAXIA

GOTA vs DDPC — DIFERENÇAS

Aspecto	Gota (Hiperuricemia)	DDPC (Pirofosfato)
Cristal	Monourato de sódio (MUS) — agulhas negativas birrefringência	Pirofosfato de cálcio (CPP) — romboides fracamente positivos
Articulação	1a MTF (podagra), tornozelo, joelho — assimétrico	Joelho, pulso, quadril — pseudogota
Epidemiologia	Homem >50 anos, hiperuricemia (>7 mg/dL)	Idosos, associado a hiperCa, hiperPTH, hemocromatose
Diagnóstico	Clínico + ácido úrico (pode ser normal na crise)	Radiografia: condrocalcinose; líquido: CPP
Laboratório	Ácido úrico elevado (mas pode ser normal na crise!)	Cálcio, PTH, ferritina (causas secundárias)
Tratamento da crise	AINE, colchicina, corticoide	Igual à gota — mesmos anti-inflamatórios

MANEJO DA CRISE AGUDA DE GOTA

CRISE GOTOSA — IDENTIFICAR + ANTI-INFLAMATÓRIO



TRATAMENTO HIPOURICEMIANTE — INDICAÇÕES E DOSES

Droga	Indicação / Mecanismo	Dose e Alvo
Alopurinol	>=2 crises/ano, tofos, urolitíase, nefropatia gotosa	100 mg/d — aumentar 100 mg/mês até AU <6 mg/dL
Febuxostate	Intolerância ao alopurinol; mais potente	80-120 mg/d; ajuste renal menos necessário
Colchicina (profilaxia)	Profilaxia de crise ao iniciar hipouricemiante	0,5 mg/d por 3-6 meses
AINE (profilaxia)	Alternativa à colchicina	Dose baixa por 3-6 meses ao iniciar alopurinol
Uricosúricos (probenecida)	Hipoexcretors (AU urinário <800 mg/24h)	Aumenta excreção renal — evitar com litíase úrica

ARTRITE SÉPTICA — DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL URGENTE

PUNÇÃO ARTICULAR SE DUVIDA ENTRE GOTA E SÉPTICA

- Artrite séptica: leucócitos no líquido >50.000/mm³ (PMN >75%), Gram e cultura positiva
- Gota: leucócitos 5.000-50.000, cristais de monourato, Gram negativo
- Febre alta + articulação comprometida + fator de risco (imunossupressão): punção obrigatória
- Artrite séptica NÃO excluída por hiperuricemia — podem coexistir
- Tratamento séptica: ATB IV (oxacilina ou cefazolina) + drenagem articular
- Não tratar como gota sem excluir infecção — atraso aumenta destruição articular

TOFOS E GOTA CRÔNICA

Tofos Gotosos

- Depósito de cristais de MUS em tecidos moles: orelha, olécrano, tendão aquileu, dedos
- Indicam gota crônica não controlada (AU alto por anos)
- Podem ulcerar, infectar, causar deformidade articular
- Indicação de hipouricemiante: alopurinol para reduzir massa de tofos
- Cirurgia: apenas tofos com infecção ou deformidade funcional grave
- Alvo AU com tofos: <5 mg/dL (mais agressivo que gota sem tofos)

Hiperuricemia e Doenças Associadas

- Síndrome metabólica: HAS, DM, obesidade, dislipidemia — tratar a síndrome
- IRC: reduz excreção de AU; ajustar alopurinol (CICr <30: max 100 mg/d)
- Diuréticos tiazídicos: aumentam AU por redução da excreção
- Ciclosporina: principal causa de gota em transplantados
- Dieta: evitar carnes vermelhas, frutos do mar, frutose, álcool (cerveja especialmente)
- Hidratação: >2 L/dia reduz precipitação de cristais

CRISE DE GOTA — PONTOS-CHAVE

NAO ERRAR

- ☐ Ácido úrico NORMAL não exclui gota na crise aguda (AU cai durante inflamação)
- ☐ NAO iniciar alopurinol durante crise aguda — piora a crise (mobilização de cristais)
- ☐ NAO mudar dose de alopurinol durante crise — instabilidade de AU precipita crise
- ☐ Colchicina: mais eficaz nas primeiras 12-24h da crise; após 72h: eficácia menor
- ☐ Renal: colchicina reduzir dose se CICr <50; AINE evitar se IRC
- ☐ Punção articular: sempre se diagnóstico duvidoso (excluir séptica)

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Homem de 58 anos com dor intensa no primeiro pododáctilo direito, edema e rubor. Ácido úrico = 6,8 mg/dL. Qual é o diagnóstico e a conduta?

- A) Gota excluída — ácido úrico normal; investigar artrite séptica
- B) Gota (podagra) provável — ácido úrico pode ser normal na crise; AINE ou colchicina + iniciar alopurinol imediatamente
- C) Gota (podagra) provável — AINE ou colchicina na crise; adiar alopurinol para após resolução da crise (2-4 semanas)
- D) DDPC — tratar com colchicina IV
- E) Celulite — antibiótico oral

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a droga de escolha para profilaxia de crise ao iniciar alopurinol?

- A) Prednisona 20 mg/dia
- B) Colchicina 0,5-1 mg/dia por 3-6 meses
- C) Alopurinol em dose baixa
- D) Febuxostate 80 mg/dia
- E) Probenecida

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Artrite séptica de joelho se diferencia da gota pelo líquido sinovial com:

- A) Cristais romboides de birrefringência fracamente positiva
- B) Leucócitos <1.000/mm³
- C) Leucócitos >50.000/mm³ com predomínio de PMN + Gram/cultura positiva
- D) Ácido úrico elevado no líquido
- E) Glicose elevada no líquido articular

QUESTÃO 4

SES-DF / Adaptada

Paciente com IRC (ClCr 25 mL/min) e gota crônica. Qual medicamento deve ter dose REDUZIDA para profilaxia de crises?

- A) Prednisona
- B) Colchicina — ClCr <50 reduz dose; ClCr <10 contraindicada
- C) Indometacina
- D) Alopurinol pode ser mantido sem ajuste
- E) Febuxostate requer ajuste renal significativo

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Por que o ácido úrico pode estar NORMAL durante uma crise aguda de gota?

- A) Porque gota pode ocorrer sem hiperuricemia — são doenças diferentes
- B) Porque a inflamação mobiliza os cristais do soro e os precipita no espaço articular, reduzindo temporariamente o AU sérico
- C) Porque os rins excretam mais AU durante a inflamação
- D) Porque o AU é consumido pelos leucócitos durante a crise
- E) Porque o resultado laboratorial é impreciso durante inflamação

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Gota aguda (podagra): AINE ou colchicina na crise. Alopurinol NAO iniciar durante crise — mobiliza cristais e piora inflamação. AU normal não exclui gota (cai durante inflamação). Iniciar alopurinol 2-4 semanas após resolução com profilaxia com colchicina.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Profilaxia ao iniciar hipouricemiante: colchicina 0,5 mg/d por 3-6 meses. Reduz crises precipitadas pelo início do alopurinol (mobilização de cristais). Alternativa: AINE dose baixa. Sem profilaxia: 50% dos pacientes têm crise nos primeiros meses de alopurinol.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Artrite séptica: leucócitos >50.000/mm³ (predomínio PMN) + Gram/cultura positiva. Gota: leucócitos 5.000-50.000, cristais de MUS, Gram negativo. A punção articular é obrigatória sempre que houver dúvida entre gota e séptica — podem coexistir!

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Colchicina na IRC: excretada predominantemente pelos rins. ClCr 30-50: dose reduzida (0,5 mg/d máx). ClCr <30: uso com extrema cautela ou evitar. ClCr <10 ou diálise: contraindicada. AINE: evitar em IRC (nefrotóxico). Alopurinol: reduzir dose conforme ClCr (máx 100 mg/d se ClCr <30).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Durante crise aguda, a inflamação e citocinas causam mobilização dos cristais de MUS do plasma para o espaço articular — reduzindo transitoriamente o AU sérico. Por isso, AU normal NAO exclui gota. Dosar AU 2-4 semanas após resolução para avaliar hiperuricemia basal.

SM24
Suporte ao Plantão Médico